

DISPENSA DE LICITAÇÃO — ART. 75, VIII, LEI N.º 14.133/2021

Processo Administrativo n.º 2026.00003

---

# Justificativa de Situação Emergencial

---

Aquisição de Autoclave Hospitalar a Vapor  
Central de Material e Esterilização — CME  
Hospital Municipal Vó Mundoca — Borba/AM

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Secretária de Saúde: | Cíntia Roque da Silva Felipe — Decreto n.º 0004/2025-GPMB |
| Diretor Hospitalar:  | Daniel Gomes Vinhote — Decreto n.º 0630/2026              |
| Valor estimado:      | R\$ 200.000,00 — Emenda Parlamentar Estadual (ALEAM)      |
| Rel. de Inoperância: | 05 de março de 2026                                       |
| Elaborado em:        | Borba/AM, 15 de março de 2026                             |

**Quadro de Identificação do Processo**

|                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo            | 2026.00003                                                                                                                                                   |
| Unidade solicitante | Secretaria Municipal de Saúde — Borba/AM                                                                                                                     |
| Setor / local       | Central de Material e Esterilização (CME) — Hospital Municipal Vó Mundoca                                                                                    |
| Secretária de Saúde | Cíntia Roque da Silva Felipe — Decreto n.º 0004/2025-GPMB                                                                                                    |
| Diretor Hospitalar  | Daniel Gomes Vinhote — Decreto n.º 0630/2026                                                                                                                 |
| Objeto              | Aquisição de autoclave hospitalar a vapor, tipo B (pré-vácuo), câmara ≥ 100 L, com periféricos, logística CIF Borba/AM, qualificações QI/QO/QD e treinamento |
| Equip. substituído  | Autoclave nº 6897 — Phoenix Luferco — fab. 2019 (~6 anos de uso)                                                                                             |
| Fundamento legal    | Art. 75, VIII, Lei n.º 14.133/2021 — Dispensa por emergência                                                                                                 |
| Fonte de recursos   | Emenda Parlamentar Estadual — Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM)                                                                                     |
| Valor estimado      | R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)                                                                                                                          |
| Rel. de Inoperância | 05 de março de 2026 — Relatório Técnico de Inoperância/Insuficiência, assinado pelo Diretor Hospitalar                                                       |

## 1. Fundamento Legal

### BASE LEGAL

Art. 75, VIII — “É dispensável a licitação [...] nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas [...] e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial.”

A presente Justificativa fundamenta-se no art. 75, VIII, da Lei Federal n.º 14.133/2021. Os elementos fáticos demonstram o preenchimento **cumulativo** dos quatro requisitos legais que legitimam a contratação direta:

1. **Situação emergencial concreta e documentada**, não provocada por omissão da Administração;
2. **Risco direto à segurança de pacientes e profissionais de saúde**;
3. **Comprometimento da continuidade de serviço público essencial de saúde**; e
4. **Objeto delimitado ao estritamente necessário** ao atendimento da emergência.

## 2. Caracterização do Município e Vulnerabilidade Geográfica

O Município de Borba, situado na calha do Rio Madeira, possui **34.869 habitantes** no perímetro urbano (IBGE 2025), estendendo sua responsabilidade assistencial a uma área de influência de aproximadamente **44 mil pessoas**, incluindo comunidades ribeirinhas e aldeias dispersas ao longo do médio Madeira.

A realidade geográfica amazônica impõe ao **Hospital Municipal Vó Mundoca** o papel de **unidade de referência isolada** para toda essa população. A ausência de outro hospital no município e os elevados custos logísticos — remoções aeromédicas ou fluviais até Manaus frequentemente superam 24 horas — tornam a autossuficiência tecnológica da unidade não apenas uma meta administrativa, mas um **imperativo de Segurança Pública e Sanitária**.

### ISOLAMENTO E IRREVERSIBILIDADE DO DANO

Em Borba, uma infecção cirúrgica grave decorrente de falha de esterilização não pode ser tratada por simples transferência a outro hospital. O tempo de traslado fluvial até Manaus varia de **15 a 40 horas** conforme a sazonalidade do Rio Madeira. Uma sepse pós-operatória sem tratamento especializado imediato disponível representa **risco direto de óbito evitável** — risco inexistente em municípios com rede hospitalar plural ou com acesso terrestre rápido.

## 3. Histórico Operacional e Dimensionamento da Demanda (2025)

A necessidade de capacidade mínima de **100 litros** é diretamente ratificada pela expressiva atividade assistencial desenvolvida no exercício de 2025. O Hospital Vó Mundoca consolidou-se como polo resolutivo regional ao realizar:

- **4 (quatro) grandes mutirões de cirurgias**, abrangendo procedimentos de média complexidade, intervenções eletivas e **cirurgias oftalmológicas especializadas** — estas de alta demanda reprimida na região Norte;
- **Fluxo ininterrupto de partos** — o centro obstétrico é o único serviço de obstetrícia disponível para toda a área de influência municipal;

- **Urgências traumáticas e clínicas**, com demanda não programável que exige materiais esterilizados disponíveis 24 horas por dia.

Esse volume evidencia que a Central de Material e Esterilização opera em **regime de saturação operacional**. O parque tecnológico atual, embora tenha sustentado essas ações, atingiu seu **limite de fadiga material**, conforme documenta o Relatório Técnico de Inoperância/Insuficiência de 05/03/2026. A especificação de 100 litros não é restritiva — é requisito funcional demonstrado pela demanda real.

## 4. Fato Gerador — Diagnóstico Técnico do Equipamento

### 4.1 Identificação do Equipamento em Inoperância

|                   |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº de patrimônio  | 6897                                                                                                                             |
| Fabricante        | Phoenix Luferco                                                                                                                  |
| Ano de fabricação | 2019 (~6 anos de uso em CME de alta demanda)                                                                                     |
| Tipo              | Autoclave hospitalar a vapor — câmara única                                                                                      |
| Status atual      | <b>INOPERANTE — falha sistêmica múltipla — uso inseguro</b>                                                                      |
| Relatório técnico | Relatório de Inoperância/Insuficiência — 05/03/2026 — Diretor Hospitalar Daniel Gomes Vinhote (Decreto n.º 0630/2026) — Anexo II |

### 4.2 Falhas Técnicas Identificadas

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F1</b> | <p><b>Salto de etapas do ciclo de esterilização</b></p> <p>O equipamento transita diretamente da fase de esterilização para a secagem sem concluir o tempo de <i>plateau</i>. Essa falha <b>invalida a garantia de esterilidade</b> de todos os artigos processados, impedindo o alcance do SAL de <math>10^{-6}</math> exigido pela RDC ANVISA 15/2012.</p>                                                                                                                    |
| <b>F2</b> | <p><b>Não atingimento da temperatura mínima de esterilização</b></p> <p>O equipamento falha em alcançar <b>134 °C ± 1 °C</b> nos ciclos de pré-vácuo. O Valor <math>F_0</math>:</p> $F_0 = \int_0^t 10^{\frac{T-121.1}{z}} dt \quad T = \text{temperatura (°C)} \quad z = 10 \text{ °C} \quad (G. stearothermophilus)$ <p>Com temperatura insuficiente, o <math>F_0</math> fica abaixo de <b>15 min</b>, tornando os artigos microbiologicamente inseguros após cada ciclo.</p> |
| <b>F3</b> | <p><b>Falha no sistema hidráulico de abastecimento automático</b></p> <p>Entrada de água inoperante — exige intervenção manual a cada ciclo, comprometendo: (i) a <b>padronização</b> dos ciclos; (ii) a <b>rastreabilidade</b> (RDC 15/2012, art. 34); e (iii) a <b>segurança do operador</b>, exposto a componentes aquecidos.</p>                                                                                                                                            |

**F4****Instabilidade geral — falha sistêmica múltipla**

Comportamento errático com parâmetros de pressão e temperatura inconsistentes. A coexistência de F1–F3 confirma **degradação estrutural simultânea** em múltiplos sub-sistemas, tornando o equipamento irrecuperável por manutenção pontual.

## 5. Biossegurança, CCIH e Controle de Infecções

A aquisição é condição técnica obrigatória para o cumprimento dos protocolos estabelecidos pela **Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)** e pelo **Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)** do Hospital Vó Mundoca. A esterilização por vapor saturado sob pressão, com monitoramento microprocessado, é a **barreira primária** contra microrganismos multirresistentes no ambiente hospitalar.

A utilização de equipamentos em estado de inoperância compromete a eficácia dos indicadores biológicos e químicos, inviabilizando o monitoramento rigoroso exigido pela RDC ANVISA 15/2012. Sob a ótica da CCIH, a insuficiência do CME eleva o risco de:

- **Contaminação cruzada** entre artigos processados em ciclos falhos e artigos conformes;
- **Surtos infecciosos pós-operatórios**, com impacto direto na morbimortalidade cirúrgica e obstétrica;
- **Infecções por microrganismos multirresistentes** (MRSA, KPC, Acinetobacter), cujo tratamento exige antibióticos de alto custo e prolongamento expressivo de internação.

### ÔNUS FISCAL INDIRETO DA NÃO AQUISIÇÃO

O custo de uma única internação prolongada por infecção de sítio cirúrgico multirresistente pode superar **R\$ 50.000,00** em antibioticoterapia e dias de UTI. Além do dano humano irreparável, a omissão na renovação do CME cria passivo fiscal e expõe o Município à **judicialização por dano ao paciente** — responsabilidade solidária do ente público (art. 37, § 6.º, CF/88).

## 6. Caracterização da Situação de Emergência

### 6.1 Impactos Operacionais e Risco de Desassistência

A inoperância da única autoclave da CME produz impactos diretos e imediatos em todos os setores assistenciais:

- **Redução crítica da capacidade de esterilização** de instrumentais médico-cirúrgicos;
- **Risco de desabastecimento** para o centro cirúrgico, **centro obstétrico**, pronto-socorro e unidades de internação;
- **Impossibilidade de garantia da eficácia do processo** — violação direta dos arts. 5.º, 6.º e 34 da RDC ANVISA 15/2012;
- Em caso de falha definitiva: **paralisação compulsória do centro cirúrgico e obstétrico**, gerando colapso assistencial em uma cidade onde **não há hospital alternativo**.

### 6.2 Risco Sanitário ao Paciente

#### CADEIA CAUSAL — FALHA DE ESTERILIZAÇÃO → DANO AO PACIENTE

Falha sistêmica →  $SAL > 10^{-6}$  → **artigo crítico inseguro** → contato com sítio cirúrgico ou obstétrico → **ISC ou infecção puerperal** → morbidade, sepse, **óbito evitável**.

Em Borba, o traslado fluvial até UTI de referência em Manaus supera 24 horas. A mortalidade por sepse sem tratamento especializado imediato pode ultrapassar 30% — risco amplificado pelo isolamento geográfico, único no contexto amazônico.

### 6.3 Conformidade Normativa e Responsabilidade Institucional

A operação da CME com equipamento inoperante configura **infração direta à RDC ANVISA 15/2012**, sujeitando o Município a:

- **Interdição sanitária** da CME pela Vigilância Sanitária, com paralisação imediata de todos os procedimentos cirúrgicos e obstétricos;
- **Sanções administrativas** ao gestor e à instituição por descumprimento de norma de biossegurança;
- **Responsabilidade civil solidária do ente público** por danos causados a pacientes em decorrência de falha de esterilização (art. 37, § 6.º, CF/88).

O **Princípio da Continuidade** do serviço público é igualmente afetado: a esterilização é atividade-meio essencial para a atividade-fim (preservação da vida). Sua interrupção fere o direito constitucional à saúde (CF/88, art. 196).

### 6.4 Impossibilidade de Aguardar o Rito Licitatório Regular

| Etapa do Pregão Eletrônico                       | Prazo mín. | Observação             |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------|
| ETP + TR + pesquisa de preços                    | 15 dias    | Já concluídos          |
| Elaboração e revisão do edital (CPL + PGM)       | 10 dias    |                        |
| Publicação no PNCP até abertura (art. 55, § 2.º) | 8 dias     |                        |
| Prazo de propostas + sessão + habilitação        | 15 dias    |                        |
| Recursos + homologação + assinatura              | 10 dias    |                        |
| Entrega Técnica — período de seca (Ago–Nov)      | 90 dias    | Balsas de menor calado |

**Total estimado até Entrega Técnica: ≈ 148 dias (≈ 5 meses)**

**CME sem esterilização segura**

O tempo de tramitação de um rito licitatório ordinário é **incompatível com a atual precariedade** do sistema de esterilização. Cirurgias e partos ocorrem diariamente no Hospital Vó Mundoca — qualquer falha definitiva do equipamento nesse intervalo implicaria paralisação imediata, sem alternativa local.

## 7. Inviabilidade da Manutenção Corretiva

A natureza **múltipla e sistêmica** das falhas F1 a F4 torna a manutenção corretiva tecnicamente insuficiente e economicamente inviável:

1. **Falha simultânea em quatro subsistemas críticos** — indica degradação estrutural, não pane pontual reparável;
2. **Paralisação adicional durante o reparo**: qualquer tentativa de manutenção corretiva implicaria a **paralisação prolongada do único equipamento de esterilização da unidade**, agravando o risco sanitário já existente durante todo o período de imobilização;

3. **Custo estimado em 60–75% do valor de substituição**, sem garantia de desempenho equivalente e sem recomposição do período de garantia;
4. **Ausência de qualificação pós-reparo**: mesmo reparado, o equipamento não seria submetido a nova QI/QO/QD auditável – mantendo incerteza sobre o SAL efetivamente alcançado;
5. **Fadiga material acelerada**: 6 anos de operação intensiva (4 mutirões + partos + urgências em 2025) em ambiente de alta umidade ( $\geq 80\%$ ) comprometem irreversivelmente guarnições, resistências e componentes eletrônicos.

#### POR QUE ESTA EMERGÊNCIA NÃO DECORRE DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA

O TCU e o TCE-AM exigem que a emergência não seja fruto de negligência. No presente caso: (i) o equipamento foi adquirido regularmente em 2019; (ii) a falha sistêmica desenvolveu-se progressivamente, abaixo do horizonte de vida útil esperado; (iii) a Emenda Parlamentar foi ativada; e (iv) a falha foi **documentada tempestivamente** em Relatório Técnico formal em 05/03/2026. A Administração agiu com diligência ao identificar, formalizar e imediatamente encaminhar a solução.

### 8. Eficiência e Economicidade

Sob o princípio da **Eficiência** (art. 37, CF/88), a aquisição de equipamento novo é a **solução mais econômica em perspectiva sistêmica**:

- **Custo acumulado de manutenções paliativas** sem resolução definitiva, somado ao tempo de imobilização do serviço a cada intervenção;
- **Desperdício de insumos por ciclos falhos**: cada ciclo com SAL  $> 10^{-6}$  implica descarte de indicadores biológicos, indicadores químicos e potencialmente do conteúdo da câmara;
- **Passivo de responsabilização civil**: uma única internação prolongada por ISC multirresistente pode superar R\$ 50.000,00 – valor comparável ao custo total de periféricos do equipamento novo;
- **Garantia e previsibilidade**: ativo novo com garantia de 24 meses e QI/QO/QD documentada oferece **desempenho auditável e previsibilidade orçamentária** – inexistentes no equipamento em estado de fadiga sistêmica.

### 9. Planejamento Estratégico e Metas para 2026

Para 2026, a Secretaria Municipal de Saúde planejou a **expansão do acesso cirúrgico** e o aumento da oferta de procedimentos para reduzir as **filas reprimidas**. A manutenção desse cronograma depende diretamente da modernização da CME. A aquisição visa dotar o hospital da infraestrutura necessária para suportar o incremento de demanda planejado, assegurando:

- A continuidade das **políticas de saúde itinerante** (mutirões em comunidades ribeirinhas);
- A expansão da **resolutividade cirúrgica local**, reduzindo remoções onerosas para Manaus;
- O cumprimento das metas do **Plano Municipal de Saúde (PMS)** e dos contratos com o SUS.

### 10. Especificação Técnica Justificada

Baseada na RDC ANVISA 15/2012, ISO 17665-1:2006 e EN 285:2015. Todos os requisitos são necessários e suficientes – sem especificação restritiva à concorrência.

Especificação

Requisito Mínimo e Justificativa

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                        | Autoclave a vapor saturado, *Tipo B (pré-vácuo)*, horizontal – obrigatório para artigos porosos e artigos com lúmens (RDC 15/2012, art. 15)                                                                                                                                                                           |
| Câmara                      | Capacidade útil $\geq 100$ litros*; aço inoxidável *AISI 316L* polido – justificada pelo volume de 4 mutirões + partos + urgências em 2025; resistência a cloretos e UR $\geq 80\%$                                                                                                                                   |
| Sistema de vácuo            | Bomba de anel líquido; pressão absoluta $\leq 30$ mbar*; *mínimo 3 pulsos* – único método eficaz para materiais porosos e lúmens (EN 285:2015, item 8)                                                                                                                                                                |
| Temperatura                 | 105 °C a 135 °C com precisão $\pm 1$ °C* – necessária para $F_0 \geq 15$ min e SAL $10^{-6}$ (ISO 17665-1:2006)                                                                                                                                                                                                       |
| Programas                   | Mínimo *13 programas* pré-configurados: poroso 134 °C, sólido 134 °C, líquido 121 °C, Bowie-Dick e Leak Test integrados                                                                                                                                                                                               |
| Interface e rastreabilidade | Tela colorida *touchscreen*, gestão de usuários com senha, *impressora integrada* de ciclos – cumpre art. 34 da RDC ANVISA 15/2012                                                                                                                                                                                    |
| Abastecimento d'água        | *Automático* – elimina a falha F3 e garante padronização e rastreabilidade dos ciclos                                                                                                                                                                                                                                 |
| Registro eletrônico         | Memória interna + saída USB – exportação de relatórios para Transferegov/SIGEM e TCE-AM                                                                                                                                                                                                                               |
| Segurança                   | Mínimo *10 sistemas de segurança*: antiesmagamento de porta, bloqueio sob pressão, alarmes sonoros e visuais; gabinete elétrico *IP 54*                                                                                                                                                                               |
| Periféricos                 | Osmose reversa 60 L/h (condutividade $\leq 1,3$ $\mu\text{S}/\text{cm}$ ); compressor de ar médico isento de óleo $\geq 50$ L (ABNT NBR ISO 7396-1:2011); cestos/racks AISI 316L $\geq 3$ un.; carro de transporte inox; IB G. stearothermophilus (cx 50 un.); IC Cl. 5 (cx 200 un.); peças de desgaste para 12 meses |
| Qualificações               | *QI + QO + QD* (ISO 17665-1:2006) no CME com carga plena; $\Delta T \leq 2$ °C; IB negativos; $F_0 \geq 15$ min – condição inafastável do TRD e do pagamento                                                                                                                                                          |
| Logística                   | *CIF Borba/AM + Entrega Técnica* – frete fluvial Manaus-Borba, seguro Ad Valorem, embalagem antivibração e antiumpidade                                                                                                                                                                                               |
| Treinamento                 | Mínimo *8 horas* presenciais no CME – operação, manutenção preventiva de 1.º nível, monitoramento biológico/químico, rastreabilidade RDC 15/2012; certificados nominais                                                                                                                                               |
| Garantia                    | Mínimo *24 meses* a contar do TRD; atendimento técnico no AM $\leq$ *72 horas*; solução definitiva $\leq$ *15 dias corridos*                                                                                                                                                                                          |
| Registro ANVISA             | Obrigatório – fabricante ou importador com registro ativo                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RENEM                       | Equipamento na RENEM com código CATMAT – exigência das Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025                                                                                                                                                                                                                             |



11. Dotação Orçamentária e Fonte de Recursos

Custeado com **Emenda Parlamentar Estadual** (ALEAM), execução via **Transferegov** (Portarias GM/MS 6.870 e 6.904/2025). Recursos vinculados à saúde – sem desvio de objeto.

| Componente                                             | Valor (R\$)       | %           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Autoclave hospitalar ≥ 100 L com barreira sanitária    | 120.000,00        | 60,0%       |
| Periféricos (osmose, compressor, racks, carro, IB, IC) | 35.000,00         | 17,5%       |
| Logística CIF Borba/AM + seguro Ad Valorem             | 15.000,00         | 7,5%        |
| Entrega Técnica (QI/QO/QD) + Treinamento (8h)          | 10.000,00         | 5,0%        |
| Peças de desgaste e consumíveis – 12 meses             | 15.000,00         | 7,5%        |
| Contingência logística – sazonalidade Rio Madeira      | 5.000,00          | 2,5%        |
| <b>Total – Emenda Parlamentar</b>                      | <b>200.000,00</b> | <b>100%</b> |

A reserva de **R\$ 20.000,00** para adequação da infraestrutura do CME (rede elétrica trifásica, ponto hidráulico e exaustão de vapor) é **recurso municipal próprio, adicional e segregado** da Emenda Parlamentar.

12. Prazo da Contratação

Trata-se de fornecimento de **bem permanente** – o contrato compreende entrega, instalação, QI/QO/QD, treinamento e entrada em operação, limitado a **1 (um) ano** (art. 75, VIII). Prazo de entrega conforme período hidrológico do Rio Madeira:

| Período      | Meses   | Condição Hidrológica                             | Prazo Máximo     |
|--------------|---------|--------------------------------------------------|------------------|
| Cheia plena  | Jan–Mai | Navegação plena; balsas de grande calado         | 60 dias corridos |
| Vazante      | Jun–Jul | Restrições incipientes; monitoramento necessário | 75 dias corridos |
| Seca extrema | Ago–Nov | Balsas de menor calado obrigatórias (ANA)        | 90 dias corridos |
| Enchente     | Dez     | Normalização progressiva                         | 75 dias corridos |

É **vedada a prorrogação** do contrato emergencial e a recontração do mesmo fornecedor sob esta hipótese (*in fine* do art. 75, VIII).

### 13. Requisitos Formais da Dispensa (Art. 72, Lei 14.133/2021)

|   | Documento                                             | Artigo        | Status                            |
|---|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ① | Esta Justificativa de Situação Emergencial            | Art. 72, I    | Elaborada — Anexo I               |
| ② | Rel. Técnico de Inoperância — Diretor Hospitalar      | Art. 72, I    | Elaborado — Anexo II (05/03/2026) |
| ③ | Termo de Referência com especificações técnicas       | Art. 72, III  | Elaborado — Anexo III             |
| ④ | Pesquisa de preços — mínimo 3 cotações formalizadas   | Art. 72, IV   | A realizar — modelo Anexo IV      |
| ⑤ | Planilha comparativa e seleção fundamentada           | Art. 72, VII  | A elaborar após cotações          |
| ⑥ | Confirmação de disponibilidade orçamentária da emenda | Art. 72, VI   | A juntar — confirmação ALEAM      |
| ⑦ | Contrato de Fornecimento                              | Art. 72, VIII | Minuta — Anexo V                  |
| ⑧ | Publicação no PNCP em até 10 dias úteis               | Art. 174      | Após assinatura do contrato       |

#### ATENÇÃO

**Dispensas por emergência de alto valor são alvo prioritário de auditoria pelo TCE-AM.** Os riscos mais comuns de glosa: (i) pesquisa de preços ausente ou com menos de 3 cotações válidas; (ii) urgência fundamentada apenas em declarações genéricas, sem Relatório Técnico objetivo; (iii) empresa sem o equipamento na RENEM; (iv) ausência de publicação no PNCP no prazo de 10 dias úteis. Esta Justificativa + Relatório de Inoperância + 3 cotações formalizadas formam o conjunto mínimo para defesa sólida em eventual tomada de contas especial.

### 14. Conclusão e Recomendação

A urgência aqui caracterizada é **objetiva, concreta e atual**. A aquisição da autoclave é o instrumento jurídico e técnico que permitirá ao Hospital Vó Mundoca continuar honrando o pacto do SUS com a população borbense — preservando a vida e mantendo a dignidade assistencial no interior do Amazonas.

✓ **Situação emergencial concreta, documentada e não provocada por omissão:** autoclave nº 6897 (Phoenix Luferco, 2019) em falha sistêmica múltipla — Relatório de Inoperância/Insuficiência de 05/03/2026 lavrado pelo Diretor Hospitalar Daniel Gomes Vinhote (Decreto n.º 0630/2026).

- ✓ **Risco direto à segurança de pacientes e profissionais**, com potencial para ISC, infecção puerperal, IRAS por multirresistentes e óbito evitável — amplificado pelo isolamento geográfico amazônico e pelo traslado de 15 a 40 horas até UTI de referência.
- ✓ **Comprometimento da continuidade do serviço público essencial**, com risco iminente de paralisação do centro cirúrgico e obstétrico e colapso assistencial em município sem hospital alternativo.
- ✓ **Inviabilidade técnica e econômica da manutenção corretiva**, inclusive pela paralisação adicional do único equipamento durante o reparo, confirmando a substituição como única solução definitiva.
- ✓ **Eficiência demonstrada**: custo de manutenções paliativas + desperdício por ciclos falhos + passivo de responsabilização civil superam o investimento em ativo novo com garantia de 24 meses.
- ✓ **Objeto delimitado ao estritamente necessário**, sem superdimensionamento — capacidade de 100 L ratificada por 4 mutirões cirúrgicos + partos + urgências em 2025.

Recomenda-se a **imediata abertura do procedimento de contratação direta**, com publicação do aviso de dispensa no PNCP (art. 72, III), instrução do processo com os documentos da Seção 13 e seleção do fornecedor com proposta mais vantajosa e equipamento na RENEM.

Borba/AM, 15 de março de 2026

**Cíntia Roque da Silva Felipe**

Secretária Municipal de Saúde  
Decreto n.º 0004/2025-GPMB

**Daniel Gomes Vinhote**

Diretor Hospitalar  
Hospital Municipal Vó Mundoca  
Decreto n.º 0630/2026

**Base normativa:** Lei n.º 14.133/2021, arts. 72 e 75, VIII • RDC ANVISA n.º 15/2012 (processamento de produtos para saúde) • ISO 17665-1:2006 (validação esterilização por calor úmido) • EN 285:2015 (esterilizadores a vapor de grande porte) • ABNT NBR ISO 7396-1:2011 (ar médico) • IN SEGES/MGI n.º 65/2021 (pesquisa de preços) • Portarias GM/MS n.º 6.870 e 6.904/2025 (Emenda Parlamentar) • CF/88, arts. 37, § 6.º, e 196.